Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Oubli de traitement

Prise oubliée, décalée ou incertaine (adulte, enfant) : ne jamais doubler la dose, faire décider l'IDE ou le médecin, tracer.

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · convulsion, ne répond pas, respire mal, malaise, après l'oubli d'un traitement.

1 · Je sécurise

- **Ne pas donner** la prise oubliée ni la suivante en double **avant l'avis de l'IDE**.
- Mettre de côté la dose non prise (pilulier, blister), sans la jeter.
- Vérifier auprès de l'équipe précédente : prise faite **sans être tracée** ?

2 · J'observe et je mesure

- Quel médicament, quelle dose, quelle heure prévue ? Depuis combien de temps ?
- **Médicament critique ?** anticoagulant, antiépileptique, insuline, antiparkinsonien, corticoïde.
- Signes depuis l'oubli : crise, tremblements, raideur, malaise ; glycémie capillaire (AS/AP) si insuline.
- Dose recrachée, vomie ou retrouvée au sol ?

3 · J'agis

- Prévenir l'**IDE** dès la découverte : elle décide (donner, décaler, sauter) avec le médecin ou le pharmacien.
- **Médicament critique** : **avis rapide**, la nuit aussi (IDE d'astreinte, médecin d'astreinte ou DOTR).
- Donner la dose décidée **seulement sur consigne** de l'IDE ou du médecin, notée au dossier.
- Enfant (IME) : prévenir les parents selon le PAI.
- Déclaration interne (fiche socle « Qui signale quoi, à qui ? »).

Je ne fais pas

- **Doubler la dose** ou rapprocher deux prises sans avis.
- Supposer que la prise a été faite parce que le pilulier est vide.
- Tracer une prise non vérifiée.
- Attendre le lendemain pour un médicament critique.

J'alerte

Appel 15 immédiat si :

- Convulsion > 5 min ou répétée sans reprise de conscience.
- Insuline oubliée : vomissements, somnolence, respiration rapide, et IDE non joignable.
- Signe de gravité et IDE non joignable tout de suite.

J'appelle l'IDE (à défaut : médecin d'astreinte ou DOTR) si :

- **Tout oubli** ou doute sur une prise, dès la découverte.
- Oubli d'un **médicament critique** : sans attendre la prise suivante.
- Glycémie < 0,70 ou > 3 g/L, pouls < 50 ou > 120/min, comportement inhabituel.

Je surveille et je trace

- Surveiller les signes liés au médicament oublié (crise, glycémie, tremblements, douleur) selon les consignes.
- Tracer : médicament, heure prévue, heure de découverte, décision prise et par qui.
- Oublis répétés : le signaler pour revoir l'organisation (horaires, sorties, week-ends, pilulier).

Mention de sécurité

Face à un oubli ou à un doute, on ne double jamais la dose : l'IDE ou le médecin décide. Un médicament critique oublié n'attend pas le matin.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : HAS, Outils de sécurisation et d'auto-évaluation de l'administration des médicaments (2011) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES), art. 2 ; CASF L313-26 ; fiche socle DOTR « Qui signale quoi, à qui ? » (10/2026).

Réf. DOTR-AS-OUBLI | Version 2.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature